

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Nephrectomy

معلومات الإقرار - نسخة المريض استئصال الكلية

1. What do I need to know about this procedure?

A nephrectomy involves removal of a kidney or part of a kidney.

The other kidney will take over the function of the removed kidney.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في إجراء استئصال الكلية تتم إزالة كامل الكلية أو جزء منها.

تقوم الكلية الأخرى بالقيام بوظائف الكلية التي تمت إزالتها.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ ورقة معلومات التخدير المقدم لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- The kidney function may fail with a need to provide artificial kidney support.
- Major bleeding from the large renal vessels. This may require surgery and possible blood transfusion.
- If part of the kidney is removed, urine may leak from the remaining kidney section. This may need further surgery.
- Removal of the rib is sometimes necessary during surgery. This may cause numbness or chest complications.
- Especially in a male, there may be difficulty in passing urine and a tube may need to be put into the bladder to drain the urine. This is usually temporary until the bladder recovers.
- Damage to the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- The bowel may be paralysed or blocked after surgery. This may cause a buildup of fluid in the bowel with bloating and vomiting. This may need further treatment.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- A weakness in the wound resulting in the wound bursting in the short term. A hernia may develop in the long term requiring further surgery.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause a bowel blockage. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.

Notes to talk to my doctor about:

- قد تفشل وظائف الكلية مما يتطلب توفير دعم صناعي للكلى (جهاز غسيل الكلى).
- نزيف شديد من الأوعية الدموية الكبيرة للكلى. قد يتطلب ذلك جراحة مع احتمال نقل دم.
- إذا أزيل جزء من الكلية ، فقد يحدث تسرب للبول من الأجزاء الأخرى للكلى التي لم تتم إزالتها. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- أحياناً يكون من الضروري إزالة أحد الأضلاع أثناء الجراحة. قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بخدر أو مضاعفات في الصدر.
- عند الذكور بصورة خاصة ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة البولية . يكون ذلك عادةً لفترة مؤقتة لحين تعافي المثانة.
- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو الشلل بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- عند بعض المرضى ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون الجرح مؤلماً.
- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزق الشق الجراحي ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق مما يتطلب جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
